

DFGSO2 / Dentaire 2A	Dentisterie Restauratrice	ED n°1
----------------------	---------------------------	--------



DFGSO2 – BORDEAUX

RONÉOS 2025/2026



Enseignant : Dr. O. KEROUREDAN	Date et horaire : 24/09/2025 16h-17h
Ronéistes :	Référents :
● Kaelye OUALI ● Clément COUBRIS	● Nour BOURIDANE ● Faiza BOUKHATMI

UE Dentisterie Restauratrice

ED n°1: Séance de Questions-Réponses (Vrai / Faux)

Question n°1 : En dentisterie adhésive, la rétention du matériau de restauration est assurée principalement par la configuration de la cavité ?

FAUX : Il faut distinguer la **dentisterie adhésive** et la **dentisterie conventionnelle**. Auparavant, les restaurations étaient réalisées avec de l'amalgame, c'est ce que l'on nomme les **plombages**. En effet, c'était la configuration de la cavité qui allait assurer la rétention du matériau, car ces matériaux comme l'amalgame n'étaient pas adhésifs. L'odontologie conservatrice conventionnelle fait appel à des matériaux qui n'adhèrent pas aux tissus dentaires. La **résistance**, la **rétention** et la **stabilité** étaient **obtenues par la forme que le praticien donnait à la cavité de curetage**. On aboutissait à un délabrement dentaire. Contrairement à l'odontologie restauratrice conventionnelle, l'odontologie restauratrice adhésive a pour but de préserver au maximum les tissus dentaires et la résistance va être permise grâce à **l'adhésion entre les matériaux et les tissus dentaires résiduels**, la dentisterie adhésive est moins invasive que la dentisterie conventionnelle.

Question n°2 : Le concept « SiSta » fait référence aux termes site et stade et permet le

diagnostic carieux en fonction de la localisation de la dent sur l'arcade et du stade évolutif de la lésion ?

FAUX : Le concept SiSta va permettre de déterminer à la fois le site et le stade de la lésion carieuse. Le diagnostic ne se fait donc pas en fonction de la localisation de la dent sur l'arcade, mais en **fonction de la localisation de la lésion carieuse au niveau des faces de la dent** concernée et en fonction du stade évolutif de la lésion.

On distingue **3 sites** de carie-susceptibilité et **5 stades** d'évolutions de la lésion carieuse :

Les Sites :

- **Site 1** : Lésions carieuses initiées au niveau des puits, des sillons, des fosses, du coagulum et autres défauts coronaires des faces occlusales. Ce site remplace la classe I de Black.

- **Site 2** : Lésions carieuses initiées au niveau des aires de contact entre dents antérieures et postérieures. C'est pour cela qu'on recommande aux patients l'utilisation du fil dentaire.

Ce site remplace les Classes II, III, IV de Black.

- **Site 3** : Lésions initiées au niveau du tiers cervical de la couronne ou à proximité de la gencive sur toute la circonférence de la dent, en vestibulaire, linguale ou palatin au niveau coronaire / radiculaire. Ceci peut être dû à une accumulation de plaque dentaire au niveau de la gencive si les patients n'utilisent pas le bon geste pour se brosser les dents. On peut retrouver des lésions carieuses au niveau de cette zone chez des patient qui possèdent un faible débit salivaire qui peut être causé par le vieillissement, la prise de certains médicaments comme les antidépresseurs, la radiothérapie et chez les patients qui consomment des stupéfiants. Ce site remplace la classe V de Black.

Les Stades :

- **Stade 0** : Lésion initiale active, superficielle et sans cavitation.

Thérapeutique : Traitement préventif, non invasif.

- **Stade 1** : Lésion avec micro cavitation de surface dans le 1/3 externe de la dentine.

Thérapeutique : Intervention restauratrice a minima.

- **Stade 2** : Lésion capitaine de taille modérée jusqu'au 1/3 médian dentinaire sans affaiblissement cuspidien.

Thérapeutique : Intervention restauratrice a minima.

- **Stade 3** : Lésion capitaine étendue jusqu'au 1/3 dentinaire avec affaiblissement cuspidien.

Thérapeutique : Comblement et renforcement des structures résiduelles.

- **Stade 4** : Lésion atteignant les zones para-pulpaire et destruction d'une partie des cuspides.

Thérapeutique : Recouvrement coronaire partiel ou total.

Question n°3 : La classification SiSta comprend 3 sites et 5 stades ?

VRAI : voir détails à la question n°2

Question n°4 : Le site 1 correspond uniquement aux lésions carieuses présentes au niveau des sillons des secteurs prémolomolaire ?

FAUX : On va distinguer les lésions en fonction de la localisation de la dent sur l'arcade dans la **classification de Black**. C'est une classification qui est utilisée que pour des obturations à l'amalgame sinon elle est peu employée actuellement en clinique. De plus, le site 1 correspond à toutes les dépressions (plis, sillon, fissure).

Question n° 5 : Le site 2 remplace les classes II, III et IV de Black ?

VRAI : Le site 2 remplace les classes 2 (zones interproximales au niveau des secteurs postérieurs), 3 (zones interproximales au niveau des secteurs antérieurs) et 4 (évolution des classes 3 avec une atteinte de l'angle incisif, par exemple une fracture de l'angle lors d'un trauma) de Black.

Question n° 6 : Dans la classification SiSta, le site 3 correspond au site cervical ?

VRAI : Il s'agit des lésions situées au niveau du 1/3 cervical ou à proximité de la gencive sur toute la circonférence de la dent, en vestibulaire, linguale ou palatin au niveau coronaire / radiculaire. Au niveau des sites cervicaux, on utilisera la résine composite. Néanmoins, ce matériau possède un inconvénient, car il est très sensible à l'humidité, donc on optera pour l'utilisation du ciment verre ionomère qui sont plus tolérants à l'humidité.

Question n°7 : Le stade 2 correspond à une lésion avec une micro cavitation de surface dans le 1/3 externe de la dentine ?

FAUX : Le stade 2 correspond à une lésion cavitaire de taille modérée jusqu'au **1/3 médian dentinaire** sans affaiblissement cuspidien.

Question n°8 : Les atteintes de stade 4 nécessitent un recouvrement coronaire partiel ou total

VRAI : Une lésion de stade 4 nécessite un recouvrement coronaire partiel ou total (des cuspides) . Lorsqu'on parle de recouvrement (restauration indirecte le plus souvent), cela fait référence aux matériaux inlay onlay overlay qui correspondent aux restaurations en céramique ou en composite. Une empreinte est réalisée afin de l'envoyer au prothésiste dentaire. Ceci est beaucoup plus conservateur que la pose d'une couronne car on va limiter la perte de substance.

Question n°9 : Le concept de « minimally invasive dentistry » vise à retarder la dégradation des dents en optant pour des solutions thérapeutiques les plus conservatrices possible.

VRAI : La dentisterie contemporaine opte de plus en plus pour des matériaux adhésifs et a pour objectif de **préserver au maximum les tissus dentaires**, car sinon, nous entrons dans une spirale de réinterventions, puisque chaque fois que l'on intervient, on enlève du tissu dentaire, ce qui finit par entraîner une perte précoce de la dent (principe du gradient thérapeutique).

Question n°10 : Les stades d'évolution représentés sur la photo correspondent à des stades 3



VRAI : On remarque sur la photo que la lésion se situe au niveau du 1/3 interne de la dentine.

Question n°11 : La lésion carieuse visible sur la radiographie nécessite une intervention restauratrice a minima



FAUX : Ce type de lésion est souvent présent chez des patients jeunes. On ne va donc pas utiliser une fraise pour réaliser une intervention restauratrice car notre instrument va être plus délabrant que la perte de substance réelle entraînée par la lésion carieuse. On n'a pas d'atteinte dentinaire, donc on va conseiller aux patients l'utilisation du fluor afin de reminéraliser l'émail. Le patient doit être vu tous les 3 mois afin de voir si tous les gestes bucco-dentaires ont été respectés et s'il n'y a pas eu d'évolution de la lésion carieuse. Ne pas oublier l'action préventive.

Question n°12 : Le score ICDAS se base sur un examen clinique et radiographique ?

FAUX : Contrairement à la classification SiSta, la classification ICDAS est fondée sur des signes visuels obtenus par un examen minutieux des surfaces dentaires nettoyées et séchées. Cette classification accorde beaucoup d'importance à l'observation clinique et ceci n'est pas évident, c'est pour cela qu'il est conseillé de s'entraîner avec les photos des différents cours afin de faciliter la détection visuelle.

Question n°13 : Cette lésion correspond à un score ICDAS 3.



FAUX : Sur cette photo, l'ombre dentinaire nous permet de détecter le score ICDAS. Il s'agit donc du score 4 car l'opacité sous-jacente nous indique bien sur le fait qu'il y a une lésion dentinaire sous-jacente à l'émail. Donc de cas-là, on a une déminéralisation du 1/3 médian dentinaire sans fragilisation des structures coronaires et cuspidiennes.

Question n °14 : Les atteintes ICDAS 1 et 2 nécessitent une reminéralisation, gestion des

facteurs de risque et des conseils préventifs.

VRAI : Pour les scores 1 et 2 on n'a pas d'infiltration bactérienne au niveau de la dentine, on optera pour des interventions à minima, faire de la prévention et gérer les facteurs de risque, et éventuellement de la reminéralisation et du scellement de sillons notamment chez les enfants. Lorsqu'on parle de reminéralisation, on peut prescrire du Fluor. Là réside l'intérêt de l'ICDAS, car il permet une intervention minimale. Une lésion carieuse, observée avec ou sans séchage, se manifeste souvent par une *tache blanche* (white spot), qui est le signe d'une hypominéralisation due à une carie. Cette tâche apparaît extrêmement blanche en raison de la perte de minéraux dans l'émail.

Petite discussion autour des facteurs préventifs de la maladie carieuse : antidépresseurs provoquent hyposialie...

Question n°15 : Un score ICDAS 5 correspond à une déminéralisation au niveau 1/3 médian dentinaire sans fragilisation des structures axiales.

FAUX : Pour un score ICDAS 5, la cavité est distincte et la dentine est visible. Ce score correspond à une déminéralisation du **1/3 interne dentinaire avec fragilisation relative des structures**.

Question n°16 : Le champ opératoire a été inventé dans les années 1960

FAUX : Le champ opératoire est bien plus ancien puisque son invention date du **XIX^{ème} siècle** (dans les années 1860-1880). Il est à noter que beaucoup de praticiens décident de ne pas le mettre malgré les recommandations. Le champ opératoire reste toutefois une pratique très importante en cabinet pour pouvoir bien travailler, avoir de bons résultats cliniques et répondre aux recommandations de bonne pratique actuelles.

Question n°17 : L'un des principaux avantages de l'utilisation du champ opératoire est de travailler dans des conditions hygrométriques optimales

VRAI : Travailler dans des conditions hygrométriques optimales est d'abord crucial dans le cadre des procédures adhésives : sinon on ne peut pas travailler avec les procédés actuels. En effet, une grande partie de la dentisterie restauratrice d'aujourd'hui est basée sur l'adhésion, qui elle-même repose sur la **siccité** des dents. Si la siccité n'est pas respectée, on peut finir par se retrouver avec des patients qui viennent nous voir en urgence car ce qu'on leur a collé n'a pas tenu.

Au-delà de cela, le champ opératoire possède aussi :

- **But ergonomique** : éviter les interruptions intempestives du patient, améliorer le confort visuel par contraste entre la couleur du champ et celle des dents
- **But thérapeutique** : limiter la contamination bactérienne et l'apport de salive au niveau de la dent (Asepsie total du site opératoire)
- **But préventif** : éviter que les patients inhalent ou ingèrent des matériaux présents en bouche + protéger les tissus mous en facilitant leur déflexion.

Question n°18 : L'utilisation du champ opératoire augmente sensiblement le temps de travail pour le praticien

FAUX : Certains praticiens ont utilisé l'excuse du temps pour justifier le fait qu'ils ne mettaient pas en place le champ opératoire dans leurs soins. Cependant, une fois que l'on est expérimenté et que l'on maîtrise sa pose, le champ opératoire constitue en réalité un grand **gain de temps** et une certaine **efficacité de travail** (moins d'échecs). On n'a alors pas besoin d'aspirer, de repousser la langue et d'éviter que les patients interrompent les soins car ils ont envie de cracher ou de parler.

Question n°19 : L'utilisation du champ opératoire en endodontie fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)

VRAI : Cela fait bien partie des recommandations de la HAS, ce qui explique pourquoi on insiste autant sur son utilisation. En effet, s'il se produit un problème avec un patient et qu'on arrive à prouver que le praticien n'avait pas mis en place le champ opératoire (alors qu'il était recommandé), ce dernier se retrouve donc complètement en tort. *Nota bene : ici, le terme "recommandation" signifie "obligation".*

Question n°20 : Je dois remplacer un amalgame par une restauration adhésive. Je dois mettre le champ opératoire après la dépose de l'amalgame afin d'éviter de souiller la feuille de digue pour mettre en place le protocole d'adhésion



FAUX : L'une des indications du champ opératoire est de le mettre en place pour la dépose d'amalgame puisque des particules de mercure peuvent être relarguées au cours de la dépose. Le champ opératoire permettra donc de protéger le patient et d'assurer sa sécurité. Il faut noter que la dépose d'amalgame est la procédure qui est la plus à risque, ce qui fait qu'elle est maintenant interdite pour les femmes enceintes et les enfants. Il est cependant encore possible de les proposer à des patients hors femmes enceintes / enfants, bien qu'il soit délicat de proposer des matériaux qui ont fait l'objet d'interdictions pour les catégories sensibles de la population. De plus, on dispose maintenant de meilleurs matériaux à disposition.

Toutefois, il arrive qu'on ait encore besoin de déposer des amalgames, en particulier pour des patients de l'ancienne génération qui, pour beaucoup, ont de l'amalgame en bouche (cela arrive même dans la génération actuelle). D'ailleurs cela fait partie des recommandations de la HAS.

Question n°21 : La mise en place du champ opératoire est contre-indiquée chez les patients allergiques au latex

FAUX : Il faut faire attention lorsqu'on fait le **questionnaire médical** : les allergies au latex sont assez fréquentes. Il existe pour cela des digues **sans latex**.

Question n°22 : Les feuilles de digue épaisses à très épaisses sont préférentiellement utilisées en DRE

VRAI : Remarque : En réalité, on peut utiliser les mêmes feuilles de digue pour l'endodontie et la DRE (pratique courante à l'hôpital). Cependant, il arrive que certaines publications scientifiques mentionnent l'utilisation de feuilles de digue bleues (épaisses). Les feuilles de digue épaisses ont l'avantage de repousser les tissus gingivaux plus bas que les feuilles souples. Elles permettent une meilleure visualisation de l'anatomie, mais n'ont aucun intérêt en endodontie.

Question n°23 : Cette image montre une pince de Brewer



FAUX : Cette image montre une **pince d'Ainsworth** (= pince à perforer)

Question n°24 : Ce crampon permet une rétention intra-sulculaire



VRAI : Cette image présente un **crampon à ailettes** qui permet d'avoir une rétention intra-sulculaire ⇔ dans le sulcus. Ce type de crampon est nécessaire lorsqu'une carie est très **juxta-gingivale**, voire **infra-gingivale**. On cherche alors à s'accrocher à la dent au niveau de la racine, en sous-gingival.

→ Remarque : lorsqu'on pose ce type de crampon, on réalise généralement une anesthésie.

Question n°25 : Ce crampon est utilisé préférentiellement sur les prémolaires



FAUX : Cette image représente un **crampon papillon** qui est surtout utilisé sur le secteur **incisivo-canin** pour l'endodontie. → Par exemple : si un angle est cassé sur une incisive, ce type de crampon très volumineux permet de manipuler correctement le matériau et le champ opératoire.

Question n°26 : Le crampon à ailettes permet une mise en place plus aisée et est adapté aux patients avec une ouverture buccale réduite



FAUX : Les crampons avec ailettes sont très volumineux, c'est-pourquoi on privilégie des crampons sans ailettes pour les patients à ouverture buccale réduite. Ces derniers sont plus simples à mettre en place.

Question n°27 : Les wedgets peuvent se substituer aux crampons pour la mise en place du champ opératoire

VRAI : Si l'on n'a pas besoin de travailler très cervicalement sur la dent, les wedgets peuvent se substituer aux crampons. Ils bloquent bien la digue, sont **moins traumatisants** pour les dents et **moins désagréables** pour le patient. Souvent, en utilisant les wedgets, on n'a donc pas besoin d'anesthésier les dents.

Question n°28 : Les ligatures sont essentielles pour isoler correctement la dent à préparer en cas de lésion juxta ou sous-gingivale

VRAI : les ligatures permettent de resserrer la digue ; on tire de manière apicale afin de repousser au maximum la digue et les tissus gingivaux. La dent sera ainsi bien isolée.

→ Remarque : la pose de ligature nécessite d'être accompagnée d'une petite anesthésie de la gencive.

Question n°29 : La digue liquide est un matériau de calfatage chémozpolymérisable

FAUX : La digue liquide est un matériau **photopolymérisable** : le matériau prend effet grâce à l'exposition lumineuse.

Question n°30 : Dans la méthode avec ailettes, il est important de passer la feuille de digue sous les ailettes pour garantir l'étanchéité du champ opératoire

VRAI : Il faut passer la feuille de digue en-dessous des ailettes. Si cette manipulation n'est pas réalisée, la salive finira par passer par-dessus le champ opératoire. On en perdrait donc tout l'intérêt.

(Chose très importante en TP, bien respecter cette indication)

Pour finir, discussion autour du 10-MDP dont le groupe phosphate permet le lien aux ions calcium (fait partie des adhésifs universels). Concernant ces derniers il faut privilégier le mordantage sélectif de l'émail plutôt que le mordantage de la dentine. Si on dépulpe

(=dévitalisée), il est préférable d'utiliser le mordantage de la dentine. Dans la majorité des cas, mordantage de l'émail, pas de la dentine. Important de connaître la physiologie du point de contact (se référer au diapo intitulé "choix du système de matriçage").